

表 2 药物的理论需水量

药 物	溶解度 (mg/ml)	剂 量 (mg)	理论需水量 (ml)
红霉素	≤0.1	500	≥5000
羟氨苄青霉素	2.5	500	200
茶 碱	8.3	200	24
阿司匹林	3.3	600	182
氨苄青霉素	6.7	500	74
盐酸四环素	100	500	5
盐酸强力霉素	333.3	200	0.6
地高辛	0.095	0.5	5

ml, 其药物的生物利用度反而降低。例如, 盐酸丙氧芬、甲磺胺心定、甲灭酸等。可能由于在空腹时水量过大、引起胃空速率太快, 肠蠕动增加、药物在胃肠道停留时间太短、使药物吸收不完全。

参 考 文 献

- [1] Bustrack J A. J Pharm Sci 1984; 73 : 1397~1400
- [2] Welling P G. J Pharm Sci 1978; 67 : 764~766
- [3] Welling P G. J Pharm Sci 1977; 66 : 549~552
- [4] Welling P G. Clin Pharmacol Ther 1975; 17 : 475~480
- [5] Koch P A. J Pharm Sci 1978; 67 : 1533~1535
- [6] Kahala P. Acta Pharmacol Toxicol 1979; 44 : 7~12
- [7] Welling P G. Antimicrob Agents Chemother 1977; 11 : 462~467
- [8] Welling P G. Clin Pharmacol Ther 1976; 19 : 559
- [9] Hamaguchi T. J Pharm Sci 1986; 75 : 891~893

安体舒通的药物相互作用

武汉市第四医院 张汉忠

提 要 本文介绍了安体舒通与排钾利尿药或钾盐、地高辛、生胃酮、华法令、非甾体抗炎药, 降压药, 皮质激素, 锂盐等药物联合应用后的相互作用, 以供临床用药参考。

关键词 安体舒通 药物相互作用 血药浓度

一、与排钾利尿药或钾盐的相互作用

一般认为通常采用的留钾利尿药安体舒通与排钾利尿药(如噻嗪类)合用。不仅出现协同作用, 且可互相纠正对血钾的两种相反的副作用。但近年来认为这两种药对钾代谢的影响不一定刚好抵消, 并用时仍需注意血钾改变, 若同时伍用钾盐则尤应注意, 以免引起致命的高血钾。800例用安体舒通治疗的病人, 常与排钾利尿药合用, 其中9例发生高血钾症; 如同时伍用氯化钾, 高血钾的发生率高达16%^[1]。故安体舒通一般禁止与氯化钾合用。

二、与地高辛的相互作用

传统认为两药同时服用, 在利尿的同时

地高辛排泄增加, 血药浓度降低。但近来认为安体舒通可抑制远端肾小管对地高辛的分泌作用^[2,8], 减少地高辛的清除, 使地高辛血药浓度显著升高。

日本Suzuki氏观察163名心衰病人^[2], 单服地高辛血药浓度为 $0.73 \pm 0.06 \text{ ng/ml}$, 口服地高辛与速尿时升至 $1.11 \pm 0.13 \text{ ng/ml}$ 合用安体舒通时地高辛血药浓度最高, 为 $1.29 \pm 0.10 \text{ ng/ml}$, 这说明利尿的同时不但未使地高辛排出增加, 相反使地高辛潴留。

Fenster等报道^[4], 安体舒通可明显升高地高辛血药浓度, 和单用地高辛比较, 稳态地高辛血药浓度升高150%。故两者合用时应减低地高辛剂量, 并测定其血药浓度, 以

免导致地高辛中毒。

三、与生胃酮的相互作用

安体舒通能减弱生胃酮对消化性溃疡的治疗作用^[5]，且对后者的钠潴留作用也减弱。故生胃酮引起的钠潴留宜用噻嗪类利尿药对抗，不宜使用安体舒通，并注意合用利尿药可加剧电解质紊乱。

四、与华法令的相互作用

由于安体舒通的肝药酶诱导作用，能显著减低口服抗凝血药物双香豆素衍生物华法令的抗凝作用及血药浓度，增加华法令的肾清除率^[6]，为保证病人用药的安全与有效，应避免同时服用安体舒通与华法令。

五、与非甾体抗炎药的相互作用

国外报道^[7]，安体舒通与非甾体抗炎药的相互作用，是阿司匹林可抑制安体舒通的利尿作用，虽机理不明，但两者不宜并用。

六、与降压药的相互作用

有报道醛固酮拮抗剂安体舒通也具有抗高血压活性^[8]，与降压药并用时降压作用增强，适用于某些血容量增高，醛固酮分泌亢进的高血压患者。

七、与皮质激素的相互作用

顽固性心衰常伴有醛固酮增高，安体舒通可竞争性地与远曲小管细胞浆激素受体结合，使醛固酮作用减弱，与皮质激素并用治疗顽固性心衰，除有利尿及抗醛固酮作用

外，还可使激素的排钾作用减弱，维持体内钾平衡。

八、与锂盐的相互作用^[9]

近来发现安体舒通与锂盐合用治疗躁狂症有协同作用，且取得满意疗效，这可能与两者都具有抗醛固酮的作用有关。6名躁狂症患者单用锂盐疗效不佳，与安体舒通合用症状得到较好控制。1例15年来躁狂反复发作患者，应用锂盐使血药浓度达0.68mmol/L，同时每天给予安体舒通100mg，24h后症状就得到控制，一周后躁狂解除。

参考文献

- [1] 叶金朝·中国医院药学杂志 1987; 7(5): 200
- [2] 于世龙·中国医院药学杂志 1984; 4(12): 10
- [3] Etsuro T et al. J Clin Pharm 1979; 19(4): 200
- [4] Fenster P E et al. Clin Pharmacol ther 1984; 36: 70
- [5] D R 劳伦斯 P N 贝内特著 於毓文等译·临床药理学·第一版·人民卫生出版社，1985: 503
- [6] 王金元·中国医院药学杂志 1985; 5(6): 16
- [7] 胡琛摘·国外药学会成药生化药制剂分册 1987; 8(3): 160
- [8] 李以欣译·药事情报通讯 1985; 4: 10
- [9] Lichtigfeld. British Medical J 1986; 292(8): 661~662

静脉滴注654-2治疗急性黄疸型肝炎疗效观察

湖北省竹溪县医院 孔繁强

1983年以来，笔者在临床工作中应用654-2静脉滴注，治疗急性黄疸型肝炎（以下简称急黄肝）120例，收到较显著的效果，现将结果报告如下：

一、病例选择：

为本院1983~1985年住院的急黄肝患者

（除暴发性肝炎外），病程3~20d，年龄60岁以下，共210例，分为两组，对照组90例，治疗组120例。

诊断标准：

按1978年杭州全国病毒性肝炎会议提出的诊断标准。